

BMed 3.8 - CLINICAL SKILLS : **ANAMNESE / STATUS DIRIGES EN PRESENCE** **D'UN ETAT FEBRILE / INFLAMMATOIRE**

08.11. - 15.11.2023, 11h15 - 12h
Auditoire Demiéville, César-Roux 19

Prof. Oscar MARCHETTI
Département de Médecine,
EHC, Morges

Service des Maladies Infectieuses
Département de Médecine, CHUV

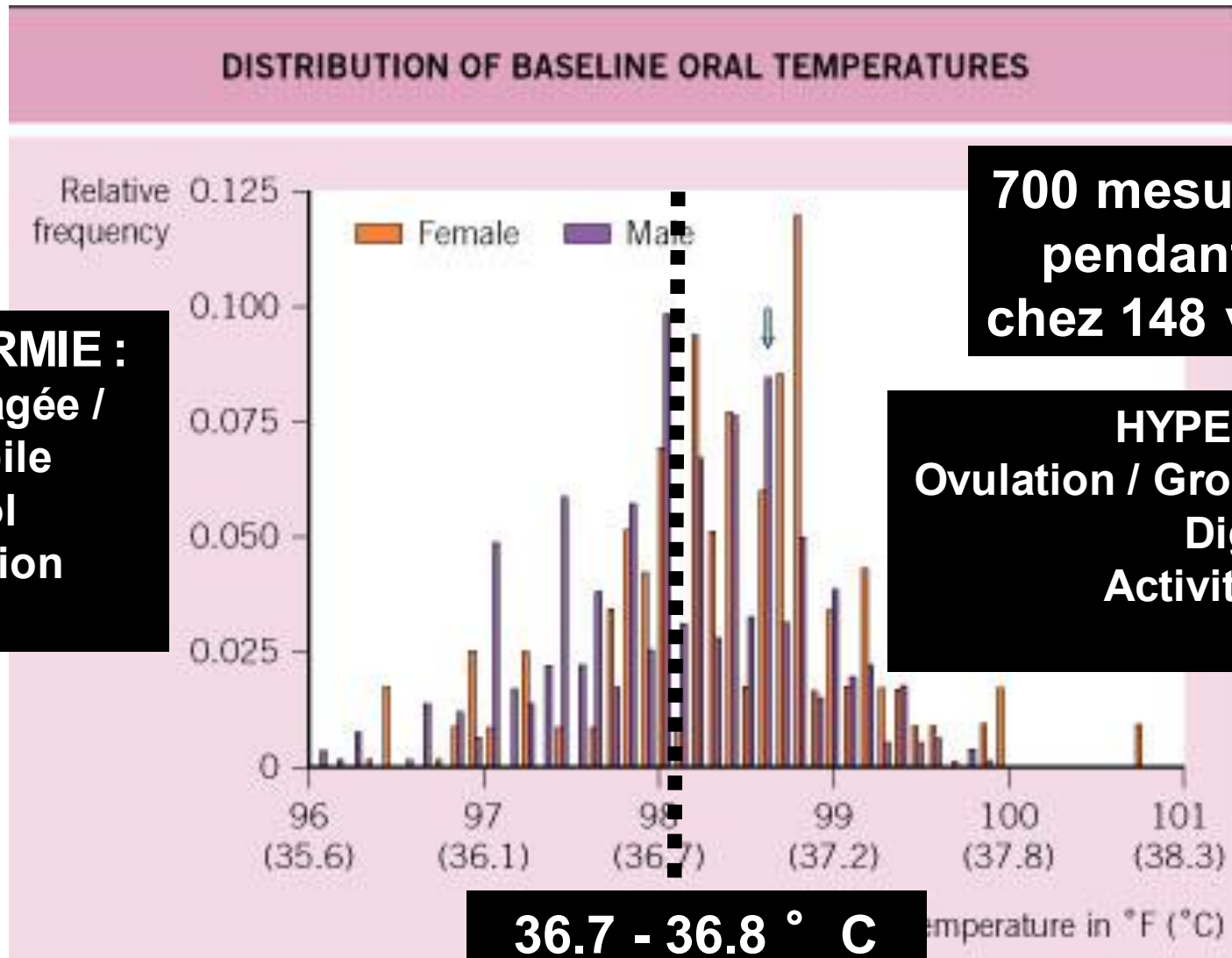
Prof. Pierre-Alexandre BART
Service de Médecine Interne
Département de Médecine, CHUV

Objectifs du Cours

- **Physiologie** de la température corporelle
- **Anamnèse et clinique** d'une fièvre d'origine
 - **Infectieuse** [+ signes de danger (**drapeaux rouges**)]
 - **Non-infectieuse** : inflammatoire,
- **Fièvre d'origine inconnue (FUO)**

Physiologie de la Température Corporelle

Température chez des Sujets Sains



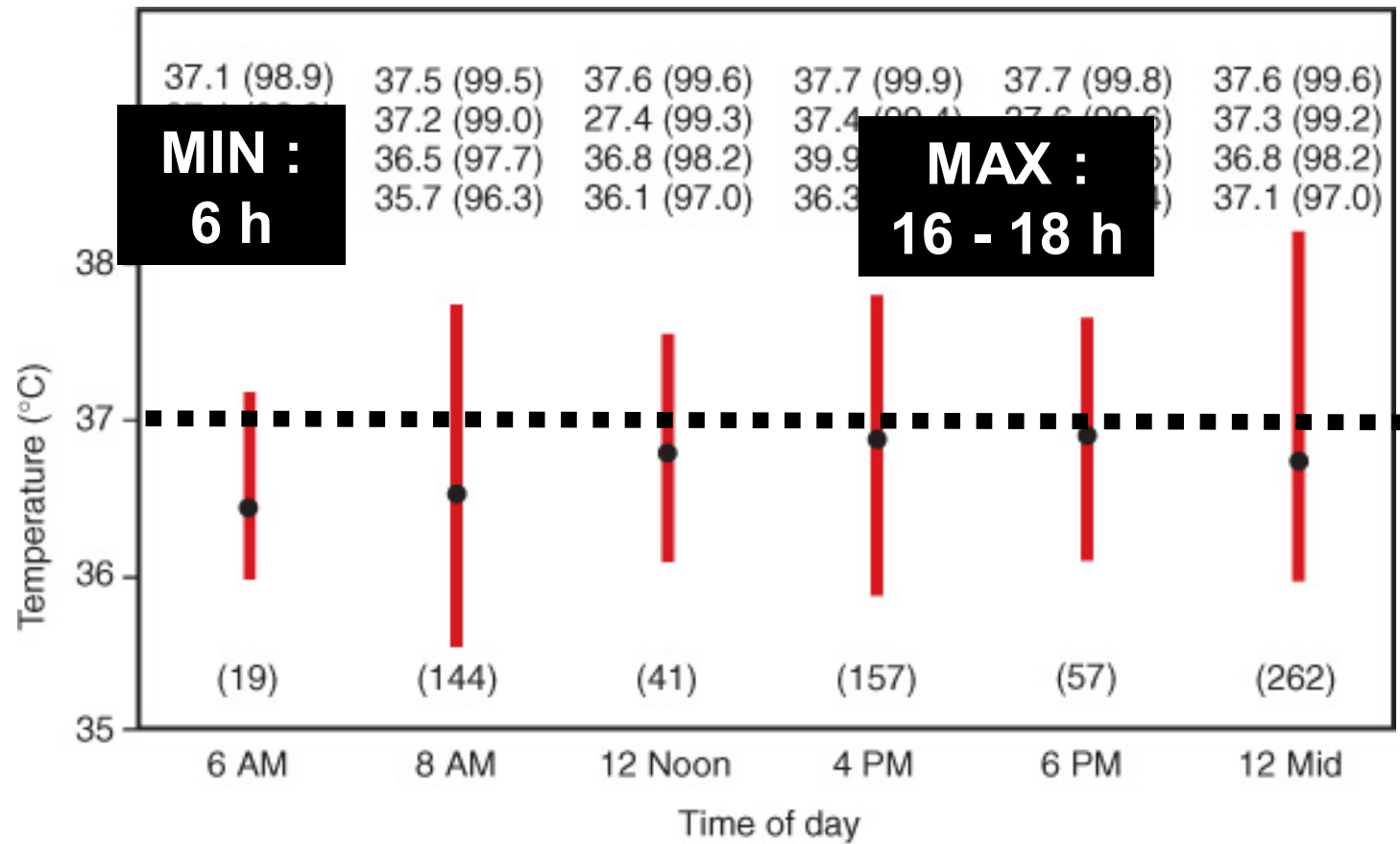
HYPOTHERMIE :
Personne âgée /
peu mobile
Alcohol
Malnutrition
Hiver

**700 mesures orales
pendant 2 jours
chez 148 volontaires**

HYPERTERMIE :
Ovulation / Grossesse / Ménopause
Digestion
Activité physique
Eté

Mackowiak et al., JAMA, 1992; 268: 1578-80

Variations de la Température pendant la Journée chez des Volontaires Sains



Cycle veille - sommeil ?!

Copyright © 2005, 2004, 2000, 1995, 1990, 1985, 1979 by Elsevier Inc.

Quand Faut-Il Suspecter un Etat Fébrile ?

Il faut mesurer la Température, si ...

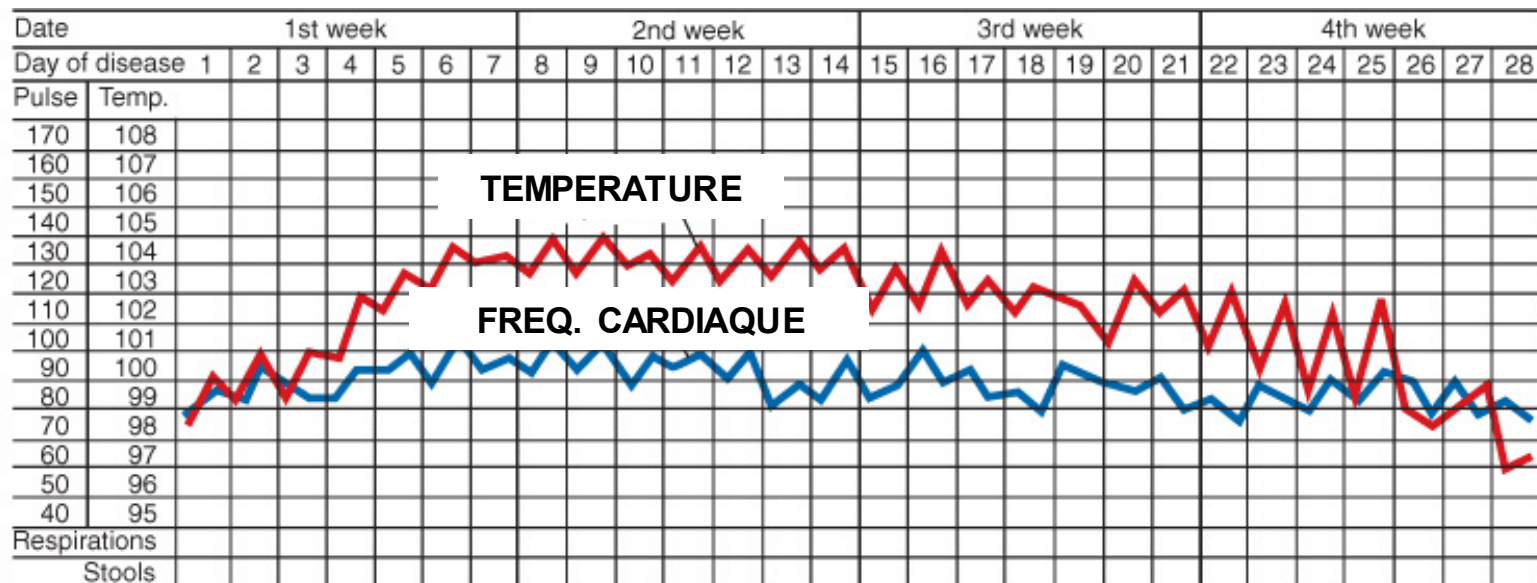
- Asthénie (fatigue) aiguë ou chronique +/- perte de poids
- Sudations, y. c. nocturnes
- Sensations de chaleur et/ou froid
- Frissons « solennels »
(« le lit tremble... » / « je claque des dents... »)
- Céphalées
- Douleurs musculaires = myalgies,
douleurs articulaires = arthralgies

Cas Clinique - 1

- Femme, 18 ans, en bonne santé habituelle
- Voyage au Maroc pendant 10 jours
- Consommation sur place de salades et eau de source
- Retour en Suisse il y a 7 jours
- Depuis 4 jours malaise, sudations, douleurs abdominales, fièvre continue $> 38.5 - 39^{\circ} \text{ C}$ avec « frissons solennels »

Fièvre Continue - Typhoïde

Hemocultures : *Salmonella typhi*



B

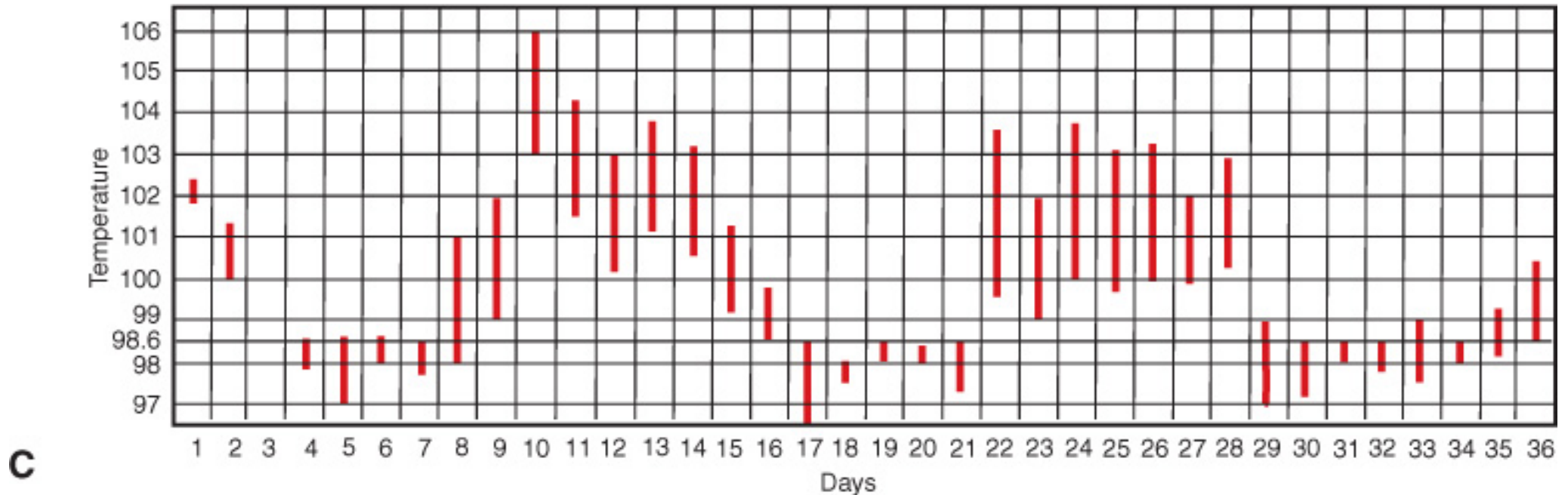
Copyright © 2005, 2004, 2000, 1995, 1990, 1985, 1979 by Elsevier Inc.

**Source : Mandell et al., Principles and Practice of Infectious Diseases,
8th Ed., 2015, Elsevier Churchill Livingstone**

Cas Clinique - 2

- Homme, 25 ans, en bonne santé habituelle
- Depuis 6 semaines, malaise, faiblesse, sudations nocturnes + sensations de chaleur, perte de 6 kg
- Périodiquement température 37.5 à 38.5 avec « petits frissons »
- A remarqué des ganglions cervicaux et inguinaux inhabituels

Fièvre Périodique - Lymphome



Copyright © 2005, 2004, 2000, 1995, 1990, 1985, 1979 by Elsevier Inc.

**Source : Mandell et al., Principles and Practice of Infectious Diseases,
8th Ed., 2015, Elsevier Churchill Livingstone**

Causes de Fièvre

- **INFECTIEUSES**

- **NON-INFECTIEUSES**

- **MALADIES INFLAMMATOIRES**

- Médicaments (Allergies - Effet central) / Vaccinations
 - Cancer + / - Lyse par Chimio- / Radiothérapie
 - Endommagement de tissus
(traumatisme / chirurgie / infarctus / nécrose / hématome)
 - Transfusions / Hémolyse
 - Thrombo-embolie
 - Hyperthyroïdie / Insuffisance surrénalienne
 - Sévrage / Délire
 - Factice
 -

Les Questions-Clé - 1

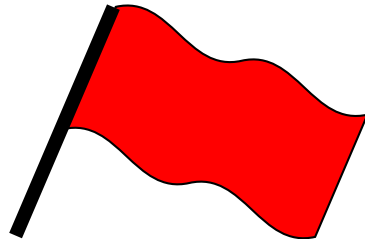
- **Timing de la fièvre** : durée ? périodicité ?
- Anamnèse familiale / personnelle **d'infections récidivantes** (prédisposition génétique) ?
- **Etat des défenses immunitaires** ?
 - Maladies chroniques ?
 - Anomalies anatomiques / fonctionnelles ?
 - Immunosuppression ?

Les Questions-Clé - 2

- **Expositions dans l'environnement ?**
 - Contacts avec malades / soignants ?
 - Contacts avec animaux (profession / loisirs) ?
 - Conditions environnement privé / professionnel ?
 - Voyages ? Origine ?
- **Foyer infectieux ?**
 - Symptômes / signes spécifiques à chaque organe / système ?

Comment Reconnaître un Patient Fébrile en Danger ?

« **DRAPEAUX ROUGES** »



Le Patient Fébrile en Danger - I

- Lymphome non-Hogkinien
- Status post-splénectomie
- Radiothérapie + corticothérapie
- Chimiothérapie (dernier cycle il y a 10 jours)
- Douleurs oropharyngées + crampes abdominales + diarrhées depuis 2 jours
- Admission aux urgences :
 - Fièvre à 39°
 - Frissons solennels

Le Patient Fébrile en Danger - I

Asplénie ?

Hypogammaglobulinémie ?

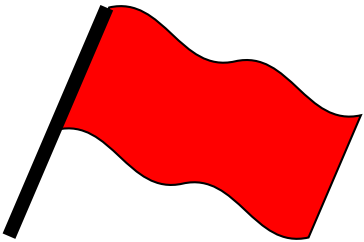
Neutropénie ?

(Infection HIV ?)

IMMUNOSUPPRESSION SEVERE



SEPSIS FULMINANT



Le Patient Fébrile en Danger - II

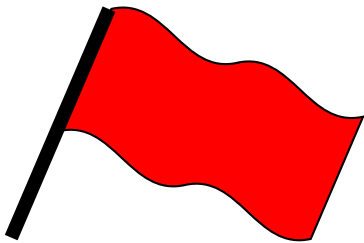
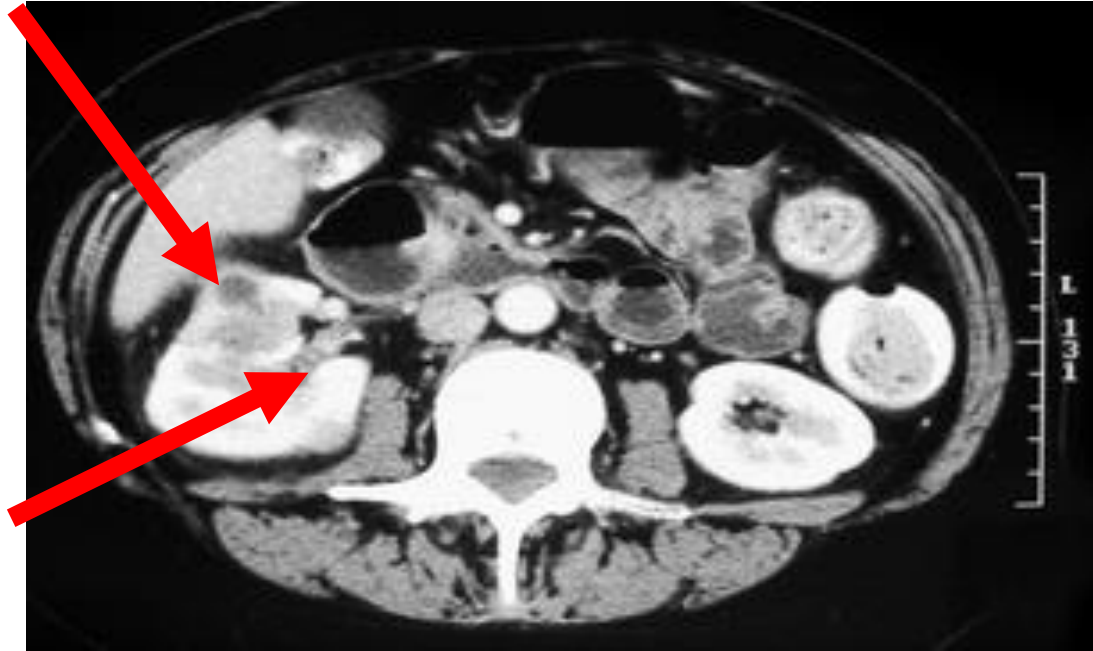
- Coliques néphrétiques récidivantes depuis des années
- Douleurs aiguës flanc gauche depuis 2 jours
- Frissons et fièvre $> 40^{\circ} \text{C}$
- Admission aux urgences :
 - Somnolence
 - Tachycardie
 - Tachypnée, saturation O_2 87%
 - TA 80 / 40 mmHg, ne réagit pas au remplissage

Le Patient Fébrile en Danger - II

Abcès Rénal

**HEMOCULTURES
+ URINE :
Urosepsis
à *E. coli***

**Hydronéphrose
sur Calcul**



HYPOTENSION / TACHYCARDIE

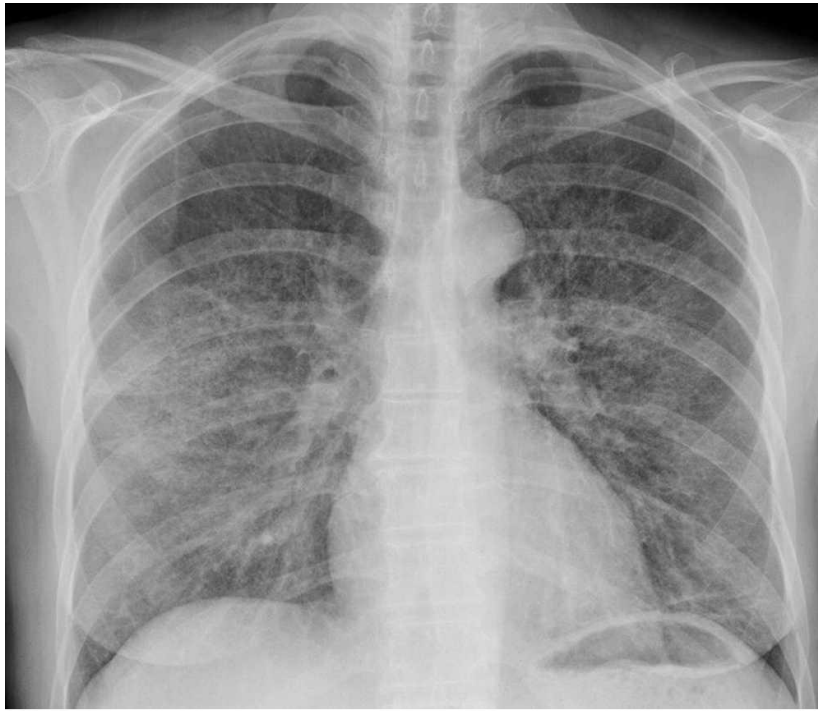
SEPSIS SEVERE / CHOC SEPTIQUE

Le Patient Fébrile en Danger - III

- Toxicomanie i.v.
- Depuis 1 semaine toux non productive
- Fièvre 38 - 39° C, sans frissons
- Dyspnée en augmentation
- Admission aux urgences :
 - T° 38.5 ° C, FC 96 / min. rég., TA 110 / 70 mmHg
 - Fréquence resp. 35 / min.
 - Saturation O2 à l'air ambiant 85%

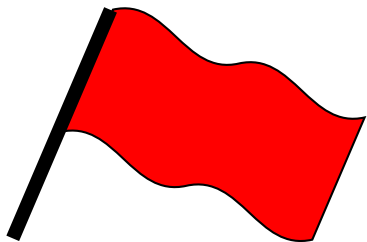
Le Patient Fébrile en Danger - III

Infection VIH avec SIDA : Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*



Thorax normal

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2015.08.001>



INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

Le Patient Fébrile en Danger - IV

- Bonne santé habituelle
- Depuis 24 heures céphalées, malaise, nausées
- Fièvre + frissons
- Admission aux urgences :
 - Température 40 °
 - Somnolence
 - Multiples pétéchies cutanées en rapide augmentation
 - Raideur de nuque

Le Patient Fébrile en Danger - IV

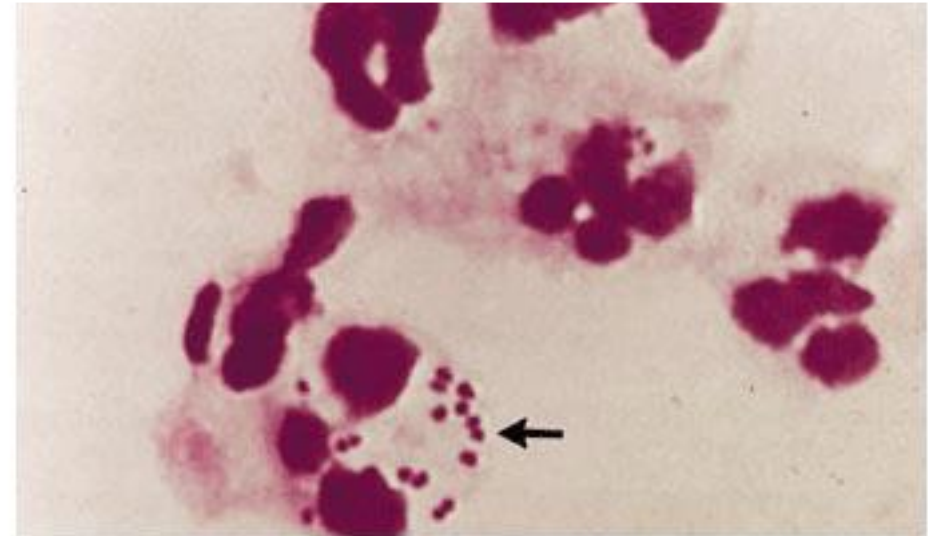
Septicémie à méningocoque

Purpura fulminans



Source : Mandell et al., *Principles and Practice of Infectious Diseases*, 8th Ed., 2015, Elsevier Churchill Livingstone

Méningite

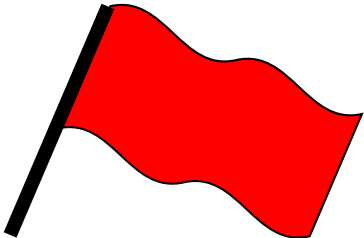


Rosenstein et al., *New Engl J Med*, 2001; 344: 1378-88

ATTEINTE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

+ / -

LESIONS CUTANÉES HÉMORRAGIQUES



Le Patient Fébrile en Danger - V

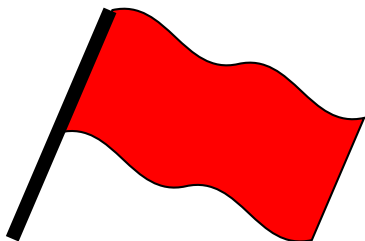
- Détartrage il y a 6 semaines
- Fatigue
- Fièvre à 38 - 38.5° C depuis 15 jours
- Consultation au cabinet :
 - « Taches douloureuses » à la plante du pied gauche
 - Souffle cardiaque, nouveau

Le Patient Fébrile en Danger - V

**Endocardite à
Streptococcus viridans
avec embolies septiques**



Source : Mandell et al., Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th Ed., 2015, Elsevier Churchill Livingstone



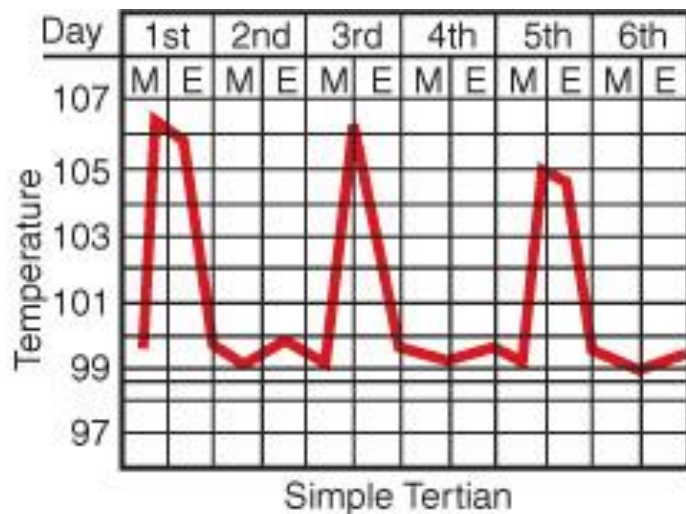
SOUFFLE CARDIAQUE NOUVEAU
+ / -
SIGNES DISSEMINATION HEMATOGENE

Le Patient Fébrile en Danger - VI

- Voyage en Thaïlande pendant 1 mois :
vaccinations / prophylaxies recommandées non effectuées
- Retour en Suisse il y a 3 semaines
- Depuis 5 jours, à jours alternés :
 - Malaise, sensations de froid, sudations, myalgies, céphalées, fièvre > 39 ° C avec « frissons solennels »
 - Se sent mieux, pas de fièvre, puis tout recommence...
- Consultation au cabinet

Le Patient Fébrile en Danger - VI

FIEVRE TERTIANE (3 JOURS) : *Plasmodium vivax / ovale*



Source : Mandell et al., *Principles and Practice of Infectious Diseases*, 8th Ed., 2015, Elsevier
Churchill Livingstone

Malaria

Piqûres moustiques, pas de prophylaxie

Inconnue

??

Infections resp.

Contacts inter-humains

Gastroentérite

Eau, nourriture

Hépatite

Eau, rapports sexuels, drogues I.V.

Fièvre de Dengue

Piqûres moustiques

Typhoïde

Eau

Tuberculose

Contact avec malades

VIH

Rapport sexuels, drogues I.V.

Fièvre hémorragique

Piqûres insectes

Rickettsiose

Piqûres

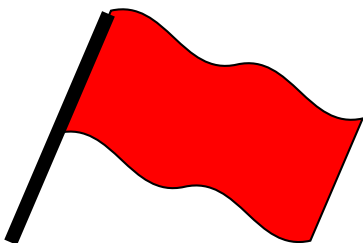
.....

.....

RETOUR DE VOYAGE

+ / -

LESIONS CUTANÉES HÉMORRAGIQUES



Infections Sévères **sans** Fièvre !

Personne âgée

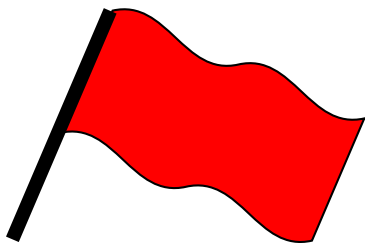
Médicaments antipyrétiques

Corticostéroïdes / Autres Immunosuppresseurs

Insuffisance rénale ou hépatique

Etat septique grave

.....



TROMPEUR, MAIS
CELA EXISTE AUSSI !

Causes de Fièvre

- INFECTIEUSES

- **NON-INFECTIEUSES**

- MALADIES INFLAMMATOIRES

- **Médicaments** (Allergies - Effet central)/Vaccinations
 - **Cancer** +/- Lyse tumorale par chimio-/radiothérapie
 - **Dommmages aux tissus**
(traumatisme/chirurgie/infarctus/nécrose/hématome)
 - **Transfusions / Hémolyse**
 - **Thrombo-embolie**
 - **Hyperthyroïdie / Insuffisance surrénalienne**
 - **Sevrage / Délire**
 - **Factice**
 -

Maladies Inflammatoires - 1

- **Vasculites**
- **Connectivites** (collagénoses) auto-immunes
- Arthrites / Arthropathies microcristallines ...
- Fièvres auto-inflammatoires (périodiques)

Maladies Inflammatoires - 2

- **Anamnèse générale**
 - Malaise, asthénie
 - Symptômes B
 - Fièvre (prolongée) + / - frissons
 - Perte poids
 - Sudations nocturnes

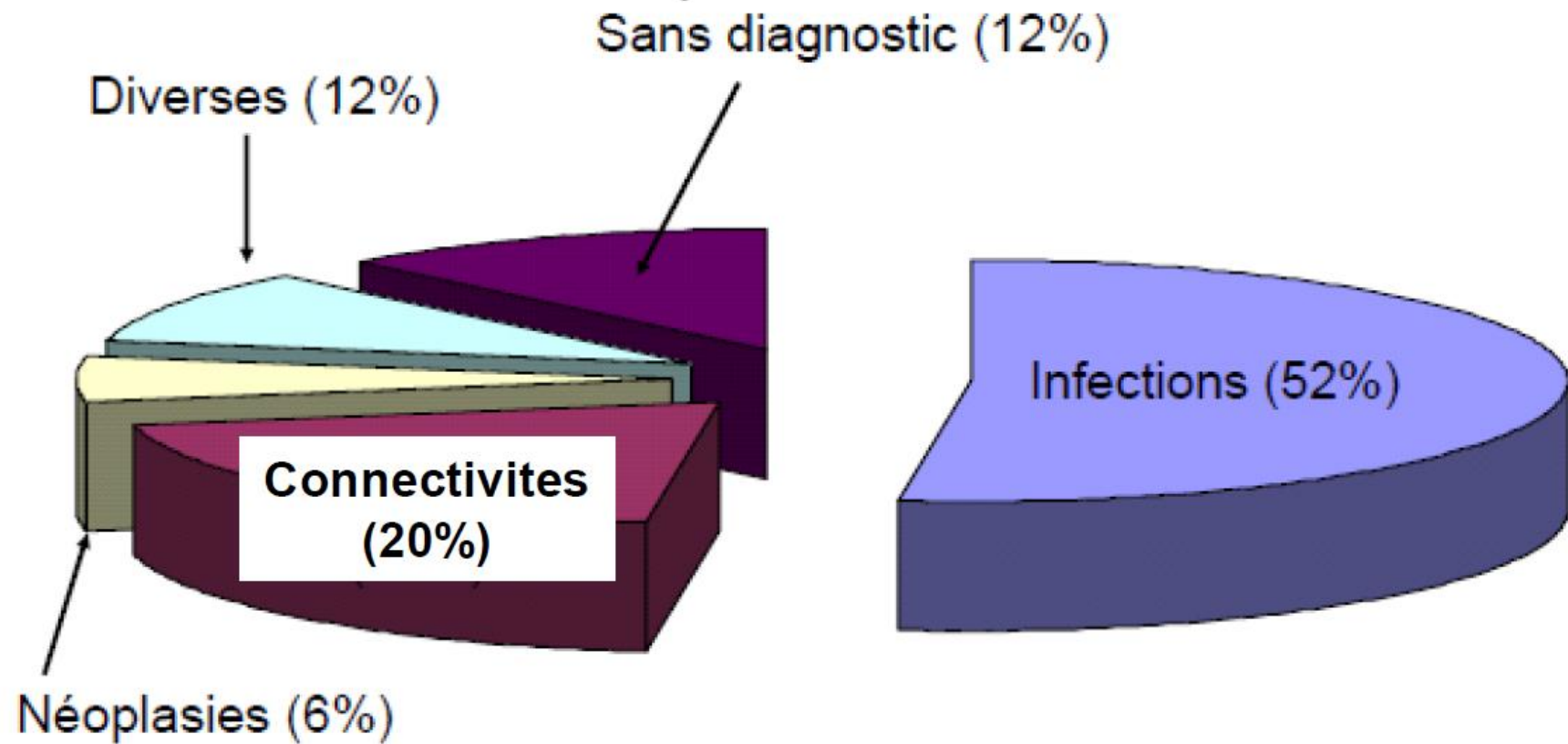
Maladies Inflammatoires - 3

- **Anamnèse par systèmes**
 - **Systèmes / Organes « nobles » = importance vitale**
 - Cœur
 - Poumons
 - Reins
 - Digestif
 - Système nerveux
 - **Systèmes / Organes évidents, mais « négligés »**
 - **Peau** (érythème / pâleur / cyanose / ulcères / nécroses ...)
 - **Yeux** (sécheresse / rougeur / douleurs / troubles visuels ...)
 - **ORL** (sécheresse / aphtes / ulcères / rhinorrhée / épistaxis ...)
 - **Ostéo-articulaire** (arthrite(s) / tendinite / synovite / type d'articulation et localisation ?)

FUO = Fièvre d'Origine Indeterminée

- Cause pas (encore) déterminée
ET TOUS les critères suivants :
- Température $> 38.3^{\circ} \text{C}$
- Durée > 3 semaines
- Evaluation
 - ≥ 3 visites ambulatoires
 - ≥ 3 jours à l'hôpital

Causes FUO



Comment Distinguer Fièvres Infectieuses et Non-Infectieuses

- **Anamnèse + Status**, y. c. identifier danger vital
- Escalade diagnostique séquentielle **d'examens complémentaires** :
 - Formule sanguine & chimie sanguine (+ / - CRP / PCT)
 - Cultures (+ / - sérologies + / - PCR)
 - Bilan immunologique (Elispot TB, auto-anticorps,...)
 - Imagerie (RX, US, CT, IRM, ...)
 - Biopsies (cultures, PCR, histo- / immuno-pathologie,...)

**Fièvre ?
Cherchez et ...
vous trouverez !**

(... presque toujours ...)